MaCro SCOPIO Orizzonti

ADERENZA ALLE PRESCRIZIONI

NELLE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI.

Analisi dei PDTA Regionali

A cura del team di **Fondazione ReS**

Irene Dell'Anno
Carlo Piccinni
Silvia Calabria
Letizia Dondi
Giulia Ronconi
Leonardo Dondi
Alice Addesi
Immacolata Esposito
Aldo Pietro Maggioni
Nello Martini

Il Pensiero Scientifico Editore

MaCro SCOPIO Orizzonti

ADERENZA ALLE PRESCRIZIONI
NELLE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI.

Analisi dei PDTA regionali

A cura del **Team di Fondazione ReS**

Irene Dell'anno
Carlo Piccinni
Silvia Calabria
Letizia Dondi
Giulia Ronconi
Leonardo Dondi
Alice Addesi
Immacolata Esposito
Aldo Pietro Maggioni
Nello Martini

Il Pensiero Scientifico Editore

SOMMARIO

PREMESSA 1

OBIETTIVO 3

METODOLOGIA 4

La fonte dati: PDTA Net 4

La ricognizione e la catalogazione dei PDTA 4

Le modalità di analisi dell'aderenza nei PDTA 6

RISULTATI 7

L'analisi dei PDTA delle patologie cardiovascolari 7

L'analisi dei PDTA dello Scompenso Cardiaco 9

Distribuzione geografica e anno di approvazione 9

I riferimenti normativi 10

L'analisi dell'aderenza 11

PDTA con aderenza "accennata": esempi 11

PDTA con aderenza "approfondita": esempi 14

PDTA con presenza di indicatori sull'aderenza 16

L'analisi dei PDTA dell'Infarto Miocardico Acuto 17

Distribuzione geografica e anno di approvazione 17

I riferimenti normativi 18

L'analisi dell'aderenza 18

PDTA con aderenza "accennata": esempi 19

PDTA con presenza di indicatori sull'aderenza 21

CONCLUSIONI 22

BIBLIOGRAFIA 23

PREMESSA

L'aderenza terapeutica è stata definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come «la misura in cui il comportamento di una persona nell'assunzione di farmaci, nel seguire una dieta e/o nel cambiare stile di vita corrisponde alle raccomandazioni concordate con un operatore sanitario».[1] Oggi il concetto di aderenza abbraccia una visione più ampia nella quale si riconosce, da un lato, un ruolo proattivo della persona rispetto al piano terapeutico e al percorso di cura, e dall'altro il coinvolgimento, oltre al medico e al paziente, di tutti gli attori del sistema salute, ciascuno con il proprio ruolo, con la propria professionalità e competenza.[2]

La corretta aderenza terapeutica è senza dubbio fondamentale per gestire in modo efficace le malattie croniche, offrendo numerosi benefici per i pazienti affetti da tali condizioni. Infatti, una scarsa aderenza causa non solo una perdita di efficacia della terapia farmacologica, ma favorisce anche l'insorgenza di complicanze, di recidive, e un aumento degli interventi di assistenza sanitaria.[3] L'impatto che ne consegue, pertanto, è negativo non solo da un punto di vista clinico, ma anche e soprattutto economico: il costo della scarsa aderenza è stimato essere di 125 miliardi di euro/anno in Europa e 105 miliardi di dollari/anno negli Stati Uniti.[4]

Il ruolo fondamentale che gioca l'aderenza terapeutica nella gestione di una patologia cronica fa sì che questo aspetto debba essere necessariamente affrontato all'interno dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) di tali patologie. Questi documenti dovrebbero prevedere infatti strategie e azioni per migliorare la capacità di assunzione di farmaci e l'aderenza alle prescrizioni da parte di pazienti (soprattutto quelli anziani, a più alto rischio sotto il profilo dell'aderenza alle terapie) che soffrono di patologie croniche.[5]

La questione dell'aderenza terapeutica rappresenta un pilastro fondamentale soprattutto nella gestione delle patologie cardiovascolari. Un recente studio ha rivelato come un incremento del 20% nell'aderenza alla terapia cardiovascolare si traduca in una riduzione del rischio di eventi cardiovascolari dell'8% e della mortalità, per tutte le cause, del 12%.[6] Nel caso specifico dello scompenso cardiaco, ad esempio, la valutazione dell'aderenza dovrebbe essere tra gli obiettivi da perseguire durante il primo anno di follow-up clinico del paziente, sia perché questo rappresenta il periodo più importante per la messa a punto di un piano terapeutico, sia perché l'aderenza al primo anno è un indicatore attendibile dell'aderenza a lungo termine.[7]

Alla luce di queste considerazioni, congiuntamente alla trattazione del tema dell'aderenza terapeutica, un PDTA "ideale" dovrebbe riportare anche "indicatori" appropriati per poterla

valutare, ossia dovrebbe prevedere al suo interno variabili misurabili per consentire una valutazione/misurazione sintetica dell'aderenza, primo passo per poter intraprendere delle azioni mirate volte al miglioramento della stessa.[4] Non a caso, infatti, tra i 10 indicatori previsti dal "Nuovo sistema di Garanzia per il monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza" (NSG LEA) per il monitoraggio e la valutazione dei PDTA[8], due riguardano proprio l'aderenza. Uno riguarda i pazienti affetti da BPCO (PDTA 01) e l'altro i pazienti affetti da scompenso cardiaco (PDTA 03).[4]

Nonostante ciò, nel passato si è assistito a una proliferazione di indicatori rivolti al monitoraggio dell'aderenza che hanno finito per generare confusione e perdita di fiducia nei confronti di questi importanti strumenti di valutazione. È dunque necessario ricordare i principali parametri da tenere in considerazione per scegliere gli indicatori di aderenza da inserire in un PDTA:[4]

- applicabilità a tutte le realtà (Regioni/ASL), raggiungibile impiegando una fonte dati comune (es. Database amministrativi);
- livello di applicazione del singolo indicatore riferibile all'intera popolazione, anziché al singolo caso;
- setting assistenziale, considerando le differenze derivanti dal diversi setting di cura;
- validazione con esito, effettuando studi in grado di verificarne l'associazione con esiti clinici e/o economici.

Nonostante la validità di queste considerazioni, va sottolineato che non esiste nessun obbligo normativo riguardo la strutturazione dei PDTA. Infatti, come evidenziato in precedenza, i PDTA pubblicati dalle Regioni Italiane e in vigore a livello nazionale sono estremamente eterogenei per denominazione, struttura e patologie trattate, varietà causata principalmente dall'assenza di un osservatorio istituzionale e di una cultura condivisa e armonizzata dei PDTA.[9-12]

In un tale scenario, per giungere al corretto inserimento di un farmaco da assumere in maniera continuativa in un PDTA, è fondamentale fare in modo che il tema dell'aderenza sia affrontato e monitorato lungo il percorso. Prima di individuare metodologia e strumenti di analisi appropriati, è quindi indispensabile valutare lo stato dell'arte di come questa sia stata affrontata nei documenti già pubblicati, in modo da sottolineare eventuali criticità e poterle quindi superare.

OBIETTIVO

Il presente report ha l'obiettivo di analizzare nel dettaglio come i PDTA regionali di due specifiche patologie cardiovascolari, scompenso cardiaco e infarto miocardico acuto (IMA), hanno affrontato il tema dell'aderenza alle prescrizioni farmacologiche.

Impiegando la piattaforma PDTA Net di Fondazione ReS sono individuati e analizzati i documenti regionali di queste due patologie, al fine di illustrarne similitudini e differenze per ciò che concerne il tema dell'aderenza, nonché per individuare e discutere eventuali indicatori riportati per monitorarla.

METODOLOGIA

La fonte dati: PDTA Net

Dal 2018 Fondazione ReS monitora i PDTA approvati dalle Regioni e Province Autonome italiane tramite uno specifico osservatorio denominato PDTA Net.

PDTA Net ha l'obiettivo di osservare e analizzare come il PDTA viene inteso dalle istituzioni sanitarie regionali, allo scopo di fare chiarezza su questo strumento e creare una risorsa utile per gli stakeholder coinvolti (istituzioni sanitarie locali, regionali e ministeriali, professionisti sanitari, ricercatori, pazienti e aziende private operanti nel settore sanitario).

Il database di PDTA Net viene aggiornato annualmente con tutti i nuovi documenti approvati e pubblicati da Regioni e Province autonome che rispondono ai criteri propri del PDTA riportati nella guida MaCroScopio "Costruisci PDTA"[13] e che sono rinvenuti tramite una accurata ricerca nei siti web istituzionali. I documenti prodotti da associazioni di pazienti, società scientifiche o aziende private che non prevedono una formalizzazione da parte della Regione, non sono inclusi nelle ricognizioni annuali di PDTA Net.

Tutti i contenuti di PDTA Net sono accessibili da piattaforma web based (https://fondazioneres.it/pdta/) (**Figura 1**) che consente:

- l'accesso ai PDTA regionali approvati (CERCA PDTA);
- l'analisi degli snodi assistenziali e degli indicatori di processo/esito messi in atto presso la singola Regione (CONFRONTA PDTA);
- l'interrogazione personalizzata del database (ANALIZZA PDTA).

L'accesso a PDTA Net è gratuito, previa registrazione, per i soggetti afferenti a istituzioni sanitarie, università, società scientifiche e associazioni di pazienti.

La ricognizione e la catalogazione dei PDTA

Il database PDTA Net viene aggiornato annualmente a seguito di una ricognizione dei documenti regionali effettuata sui siti istituzionali all'interno dei quali vengono ricercati tutti i documenti aventi le caratteristiche di PDTA approvati in Italia da istituzioni regionali e delle province

Figura 1. I Servizi della piattaforma web di PDTA Net.

autonome. La ricerca viene effettuata sia nelle specifiche sezioni dei siti istituzionali che riportano le normative pubblicate (es. Bollettini Ufficiali, Delibere di giunta, Decreti regionali, ecc.) sia all'interno di siti ufficiali delle Agenzie Sanitare Regionali e delle Reti attive a livello regionale (reti oncologiche e reti delle malattie rare). La ricerca avviene mediante l'impiego di specifiche parole chiave quali: "Pdta", "Percorso diagnostico", "Percorso/rete assistenziale", "Linee guida", "Gestione integrata", "Linee/ documento di indirizzo" e "Documento di consenso".

Una volta raccolti tutti i PDTA regionali ufficialmente pubblicati, questi sono censiti all'interno di un database consultabile dagli utenti accreditati sulla piattaforma mediante la funzione CERCA PDTA.

Per tutti i documenti rinvenuti sono raccolte informazioni descrittive, quali: anno di pubblicazione, Regione, patologia, riferimento normativo e link alla fonte del documento. Al fine di indicare la patologia di riferimento del documento e la relativa area clinica, a ogni PDTA viene associato uno specifico termine individuato all'interno della traduzione italiana del dizionario MeSH curata dal Settore Documentazione dell'ISS.[14] All'interno del sistema le patologie sono distinte in "Malattie Rare" e in "Malattie ad alta prevalenza".

Tramite questo sistema di catalogazione è stato possibile risalire, nell'ambito dei PDTA afferenti alle "Malattie ad alta prevalenza", a quelli relativi alle "Malattie del sistema cardiovascolare" e, tra questi, a quelli specifici per Scompenso Cardiaco e IMA.

I risultati delle ricognizioni annuali vengono pubblicati al fine di fornire un aggiornamento dello stato dell'arte dei PDTA a livello italiano.[9-12]

L'ultima ricognizione di PDTA Net ha censito tutti i documenti pubblicati fino al 31 dicembre 2023.[12]

Le modalità di analisi dell'aderenza nei PDTA

I singoli documenti oggetto del presente report sono stati analizzati allo scopo di definire il livello di approfondimento con cui era stata affrontata l'aderenza al loro interno. Il grado di approfondimento è stato categorizzato con un valore da 0 a 2:

- Livello 0=tema assente, ossia l'aderenza non compariva in nessun punto del documento
- Livello 1=tema accennato, ossia in alcune parti del documento era presente un accenno al tema dell'aderenza;
- Livello 2=tema approfondito, ossia è stata rinvenuta la presenza di uno specifico paragrafo dedicato all'aderenza.

Oltre al livello di approfondimento è stata ricercata l'eventuale presenza di indicatori volti a misurare l'aderenza. Questi sono stati descritti e analizzati in termini di applicabilità e correttezza della modalità con cui erano stati riportati nel documento.

RISULTATI

L'analisi dei PDTA delle patologie cardiovascolari

Fino al 31 dicembre 2023 sono stati censiti 856 PDTA, di cui 476 (55,6%) relativi a "Malattie ad elevata prevalenza" e 380 (44,4%) relativi a Malattie Rare. La distribuzione geografica dei PDTA delle prime ha evidenziato che tutte le Regioni e Province autonome si sono dotate di almeno un documento nel periodo analizzato (**Figura 2**).

Catalogando i PDTA per aree cliniche, emerge che l'area con il maggior numero di PDTA di Malattie ad alta prevalenza è stata l'oncologia (110 PDTA; corrispondenti al 23,1% dei PDTA), seguita dalla neurologia (64; 13,2%) e dalla cardiologia (48; 10,1%) (**Figura 3**).

Tra i 48 PDTA regionali delle malattie del sistema cardiovascolare, approvati fino al 31 dicembre 2023, 13 riguardavano lo scompenso cardiaco e 7 l'IMA (**Figura 4**).

Figura 2. I PDTA regionali approvati fino al 31 dicembre 2023

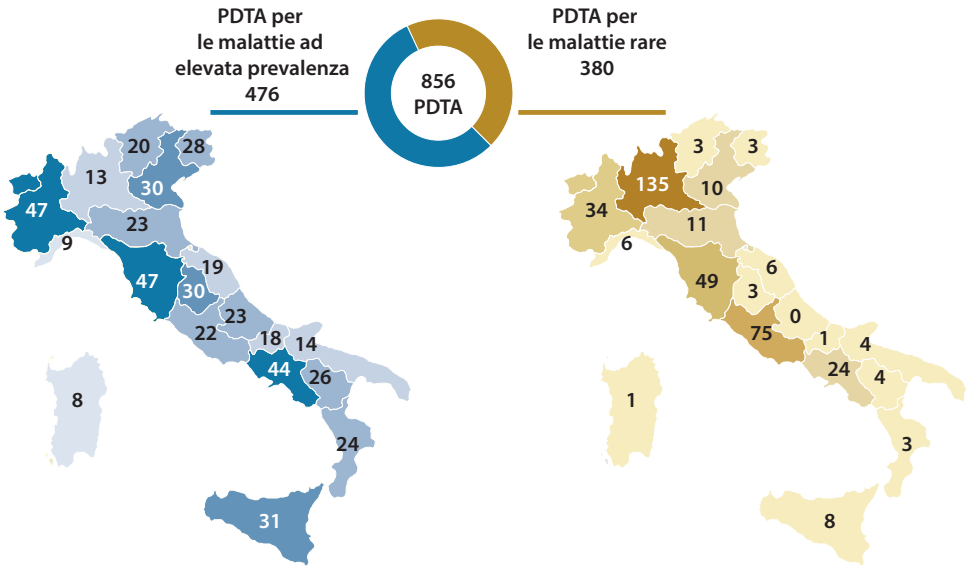


Figura 3. Aree cliniche dei PDTA delle Malattie Croniche ad alta prevalenza (numero di PDTA approvati al 31.12.2023)

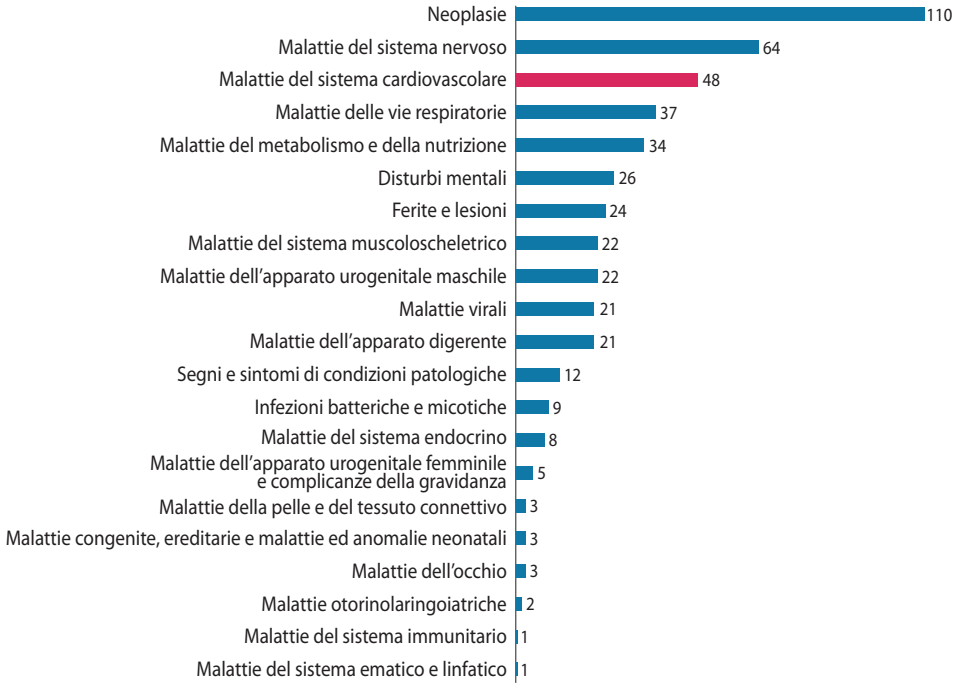
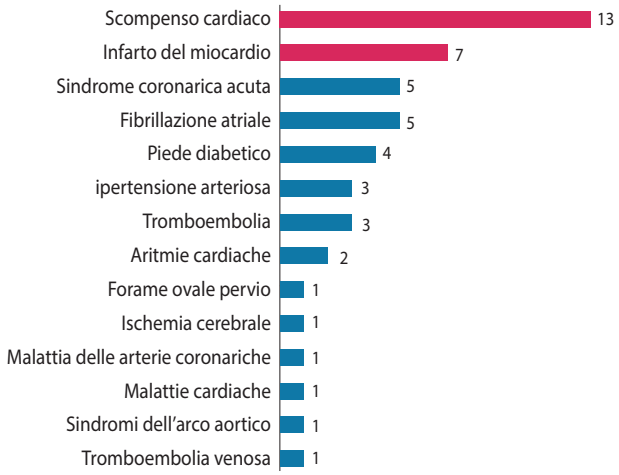


Figura 4. PDTA per le singole patologie rientranti tra le Malattie del sistema cardiovascolare (numero di PDTA approvati al 31.12.2023)



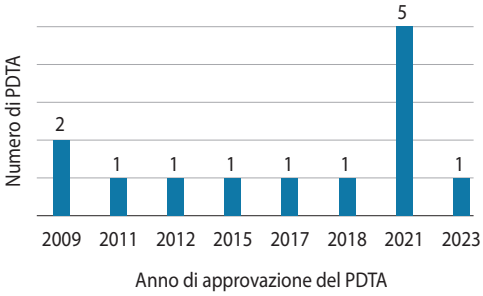
L'analisi dei PDTA dello Scompenso Cardiaco

Distribuzione geografica e anno di approvazione

Fino al 31 dicembre 2023 sono stati rinvenuti 13 PDTA regionali per lo scompenso cardiaco, rispettivamente nelle Regioni Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, Umbria, Calabria, Basilicata, Toscana, Abruzzo, Campania, Marche e Molise (**Figura 5**). Questi PDTA sono stati approvati (e/o aggiornati) tra il 2009 e il 2023 (**Figura 6**), con il picco nell'anno 2021, con 5 documenti regionali approvati.

Figura 5. La distribuzione geografica dei PDTA regionali dello scompenso cardiaco

Figura 6. Approvazioni di PDTA regionali per lo scompenso cardiaco negli anni



I riferimenti normativi

Di seguito si riporta l'elenco dei documenti analizzati con i relativi riferimenti normativi:

- PIEMONTE, "Profilo integrato di cura dello scompenso cardiaco", 2009 (Doc Aress Piemonte 2009);
- FRIULI-VENEZIA GIULIA, "Consensus «Scompenso Cardiaco» percorsi diagnostico terapeutici condivisi per i medici di medicina generale ed ospedalieri in Friuli-Venezia Giulia", 2009 (Doc ARS Friuli-Venezia Giulia 2009);
- EMILIA-ROMAGNA, "Gestione integrata del paziente con scompenso cardiaco. Linee di indirizzo", 2011 (DGR n. 1598 del 7/11/2011);
- LIGURIA, "Gestione integrata dello scompenso cardiaco", 2012 (Deliberazione n. 518 in 04/05/2012);
- LAZIO, "Scompenso Cardiaco", 2015 (Decreto del Commissario ad acta N. 0044862 del 15/10/2015);
- UMBRIA, "Regione Umbria. Piano Regionale Cronicità. Insufficienza cardiaca cronica (scompenso cardiaco)", 2017 (DGR n. 902 del 28.07.2017);
- CALABRIA, "Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per lo Scompenso Cardiaco", 2018 (Decreto n. 213 del 08 novembre 2018);
- BASILICATA, "Ottimizzazione rete integrata T-H-T Scompenso Cardiaco. Governance percorso diagnostico terapeutico riabilitativo assistenziale (PDTRA) del paziente con scompenso cardiaco cronico", 2021 (Deliberazione 16 aprile 2021, n.302);
- TOSCANA, "L'ambulatorio orientato allo scompenso cardiaco nell'ambito del Chronic Care Model" 2021 (Delibera n.473 del 04-05-2021);
- ABRUZZO, "Percorso diagnostico terapeutico assistenziale dello scompenso cardiaco cronico", 2021 (DGR n. 524 del 13/08/2021);
- CAMPANIA, "Adozione del Percorso Diagnostico-TerapeuticoAssistenziale (PDTA) Scompenso Cardiaco in Regione Campania", 2021 (Decreto Dirigenziale n. 135 del 16/04/2021);
- MARCHE, "Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione del paziente adulto con Scompenso Cardiaco sul territorio marchigiano", 2021 (DGR nr.1121 del 20/09/2021);
- MOLISE, "Percorso assistenziale per la gestione dello scompenso cardiaco", 2023 (DDG ASReM n.1592/2023).

L'analisi dell'aderenza

L'analisi dell'aderenza dei 13 PDTA dello scompenso cardiaco approvati fino al 31 dicembre 2023 ha evidenziato che tutti affrontano il tema dell'aderenza alle prescrizioni farmacologiche, ma soltanto uno (Regione Abruzzo, 2021) lo approfondisce in modo esaustivo dedicando al tema uno specifico paragrafo. Indicatori di aderenza sono stati rinvenuti soltanto in 3 dei 15 PDTA (Regioni Lazio, Umbria, Marche), che affrontano il tema dell'aderenza comunque in modo generico (Livello=1). Questi indicatori sono considerati talvolta di processo (nei documenti di Lazio e Umbria) e talvolta di esito (Marche) (**Tabella 1**).

Tabella 1. Analisi dell'aderenza per i PDTA dello Scompenso Cardiaco (livello di approfondimento e presenza di indicatori)

	Anno PDTA	Livello di approfondimento sul tema di interesse*	Indicatori	Tipologia di indicatore
Piemonte	2009	1		
Friuli V.G.	2009	1		
Emilia Romagna	2011	1		
Liguria	2012	1		
Lazio	2015	1	✓	i. di processo
Umbria	2017	1	✓	i. di esito
Calabria	2018	1		
Basilicata	2021	1		
Toscana	2021	1		
Abruzzo	2021	2		
Campania	2021	1		
Marche	2021	1	✓	i. di processo (tratti da NSG)
Molise	2023	1		

*NSG= Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza

▶ *PDTA con aderenza "accennata": esempi*

EMILIA-ROMAGNA

Nel PDTA dell'Emilia-Romagna il tema dell'aderenza è accennato in varie sezioni dedicate alla descrizione dei ruoli e compiti dei professionisti sanitari, come medico di medicina generale (MMG) e infermiere.

Nel modello di presa in carico di pazienti con scompenso cardiaco in stadio A, B, C e D, si specifica il **Ruolo degli infermieri,** quale: «Educazione sanitaria individuale del paziente e dei

suoi familiari, in particolare verifica dell'aderenza e persistenza del paziente alla prescrizione terapeutica farmacologica e allo stile di vita e alla corretta alimentazione».

Nel modello di gestione dello scompenso cardiaco noto, si parla di aderenza tra le attività del MMG e dell'infermiere:

Professionista	Attività	Sospetto diagnostico/Diagnosi	Azione
MMG	**Visita** • Valutazioni cliniche e strumentali • **Valutazione della compliance terapeutica**	**Stabilità Clinica**	Controllo periodico
		Sospetta instabilizzazione (classe NYHA II) Modifica delle condizioni cliniche del paziente	Richiesta visita cardiologica ambulatoriale entro 24 h (U)
		Sospetta instabilizzazione (classe NYHA >II) Modifica delle condizioni cliniche del paziente	Richiesta visita cardiologica ambulatoriale entro 7 gg (B)
		Sospetta instabilizzazione (classe NYHA IV) • Edema polmonare • Dispnea a riposo con ortopnea • Anasarca o severi edemi declivi con grave congestione venosa e/o oligoanuria • Aritmie minacciose e/o sintomatiche • Ipotensione (PAS < 80 mmHg) sintomatica e/o shock • Nuova evidenza clinica e/o strumentale di ischemia miocardica • Segni e sintomi di bassa portata • Refrattarietà alla terapia farmacologica orale non gestibile ambulatorialmente	Richiesta ricovero urgente
Infermiere	**Visita** • Esame obiettivo: PAS/PAD, FC, peso corporeo, BMI, reperti di congestione venosa, analisi sintomi, diuresi, classe NYHA • **Valutazione aderenza terapeutica** • Aggiornamento cartella clinica informatizzata • Monitoraggio del paziente • Counseling • Piano personalizzato di assistenza	• Parametri clinici fuori standard e/o aggravamento dei sintomi • Incremento ponderale persistente > 2-3 Kg in 2-3 giorni • Instabilizzazione del compenso: Edema polmonare acuto; FC > 120 bpm; Ipotensione arteriosa persistente e/o sintomatica; Disturbi mentali attribuibili ad ipoperfusione cerebrale • Peggioramento di classe funzionale NYHA: comparsa di dispnea, astenia, palpitazioni per attività fisiche di entità inferiore a quelle abituali (NYHA III) o a riposo (NYHA IV), con conseguente grave limitazione dell'attività quotidiana oppure anasarca e/o severi edemi declivi con gravi segni di congestione venosa (turgore giugulare) • Oligo-anuria • Disturbi del ritmo sintomatici o asintomatici • **Mancata aderenza alla terapia farmacologica e non farmacologica per problemi cognitivi del paziente e inadeguata assistenza del caregiver**	Segnalazione al MMG
		Parametri clinici invariati senza aggravamento dei sintomi	Controllo periodico secondo cadenze prestabilite

TOSCANA

Nel PDTA della Regione Toscana, il tema dell'aderenza è accennato:

- Nelle finalità del follow-up:

Il follow-up del paziente con scompenso cardiaco richiede la disponibilità di personale infermieristico formato alle problematiche clinico - assistenziali specifiche. Ha le seguenti finalità:

1. Educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari, in particolare verifica dell'aderenza del paziente alla prescrizione terapeutica farmacologica e allo stile di vita

2. Educazione del paziente all'autogestione del diuretico e all'autoanalisi di alcuni parametri quali diuresi, peso, sintomi di allarme

3. . . .

- Nei criteri di stabilità clinica a favore della domiciliazione:

1. Assenza di sintomi di congestione

2. Assenza di angina pectoris o comunque stabilità della soglia ischemica

3. . . .

11. Buona tolleranza al farmaco e completa adesione al trattamento

12. Valore del BNP o pro-BNP alla dimissione

- Nei criteri di instabilità clinica a favore dell'ospedalizzazione:

Al fine di ridurre sia i ricoveri ripetuti che la degenza media dei pazienti occorre stabilire e concordare criteri di avvio all'ospedalizzazione del paziente con diagnosi sospetta o accertata di scompenso cardiaco:

- Ricovero immediato o consulenza immediata con lo specialista di riferimento

1. . . . .

- Ricovero urgente o consulenza in giornata con lo specialista di riferimento

5. . . . .

- Ricovero rapidamente programmato o consulenza in tre giorni con lo specialista di riferimento

11. Assenza di compliance alla terapia per problemi cognitivi e inadeguata assistenza domiciliare

▶ *PDTA con aderenza "approfondita": esempi*

ABRUZZO

Nel PDTA della Regione Abruzzo, il tema dell'aderenza è affrontato in modo piuttosto approfondito. Infatti, oltre a vari accenni nelle sezioni dedicate alla descrizione dei ruoli e compiti dei professionisti sanitari, come medico di medicina generale (MMG) e infermiere, è presente uno specifico paragrafo dedicato a questo tema. Vediamo in dettaglio:

- Ruolo dell'infermiere, come «Case Manager», tra i suoi compiti:

In particolare, i compiti del «Case Manager» consistono nel:

- Fornire informazioni a pazienti e familiari sullo Scompenso Cardiaco (riunioni di gruppo, materiale informativo, diario per il paziente, informazioni sulla dicta, attività fisica, rianimazione cardio-polmonare di primo soccorso), sui fattori di rischio, sulla programmazione terapeutica formulate dallo Specialista ospedaliero, **sottolineando l'importanza dell'adesione alla terapia**;
- Fornire indicazioni riguardanti l'educazione sanitaria/terapeutica finalizzate all'empowerment, alla adozione di corretti stili di vita e al corretto use dei device e dei dispositivi medici;
- …

- Ruolo del medico di medicina generale (MMG)

  a. Nella presa in carico e gestione del paziente con scompenso cardiaco noto:

Professionista	Attività	Quadro clinico	Azione
MMG	**Visita** • Valutazioni cliniche e strumentali • **Valutazione della compliance terapeutica**	**Stabilità Clinica**	Follow up
		Sospetta instabilizzazione (classe NYHA 11411) Modifica delle condizioni cliniche del paziente	Richiesta visita
		Sospetta instabilizzazione (classe NYHA IV) Edema polmonare • Dispnea a riposo con ortopnea • Anasarca o severi edemi declivi con grave congestione venosa e/o oligoanuria-Aritmie minacciose e/o sintomatiche • Ipotensione (PAS < 80mmHg) sintomatica e/o shock • Nuova evidenza clinica e/o strumentale di ischemia miocardica • Segni e sintomi di bassa portata • Refrattarietà alle terapie farmacologica orale non gestibile ambulatorialmente	Richiesta ricovero urgente

  b. Nel follow-up:

…Per i pazienti con particolari problemi assistenziali, il MMG può avvalersi nella gestione del follow-up di assistenza domiciliare. Con accessi domiciliari programmati, il MMG controlla il paziente, **l'aderenza alle prescrizioni non farmacologiche, l'aderenza alla terapia**, la stabilità delle comorbidità che possono far precipitare uno scompenso cardiaco, il controllo del diabete, dell'ipertensione, l'eventuale insorgenza di anemizzazione, peggioramento della funzione renale, squilibri elettrolitici.

- Nei criteri di stabilità clinica, a favore della domiciliazione:

  - Assenza di sintomi di congestione
  - Assenza di angina pectoris o comunque stabilità della soglia ischemica
  - …
  - **Buona tolleranza al farmaco e completa adesione al trattamento**

- Nei criteri di instabilità clinica a favore dell'ospedalizzazione:

  Al fine di ridurre sia i ricoveri ripetuti che la degenza media dei pazienti occorre stabilire e concordare criteri di avvio all'ospedalizzazione del paziente con diagnosi sospetta o accertata di scompenso cardiaco:

  Ricovero immediato o consulenza immediata con lo specialista di riferimento

  - ....

  Ricovero urgente o consulenza in giornata con lo specialista di riferimento

  - ....

  Ricovero rapidamente programmato o consulenza in tre giorni con lo specialista cardiologo

  - **Assenza di compliance alla terapia per problemi cognitivi e inadeguata assistenza domiciliare**

- Sezione dedicata all'adesione al trattamento:

  Vi sono dati che suggeriscono che la non adesione al trattamento sia una significativa causa di ricovero per SC. Vi sono molte cause di non adesione, che può essere intenzionale o non intenzionale: quella non intenzionale è connessa a insufficienti risorse del paziente nel gestire la terapia o a oggettive barriere che rendono difficoltoso l'accesso alla terapia o la sua attuazione. Le più diffuse cause di non adesione non intenzionale sono:

  - compromissione cognitiva del paziente (deficit di memoria, di attenzione, di orientamento temporale o personale, ecc.);
  - disturbi emozionali (ansia, depressione) di entità rilevante;
  - difficolta comportamentali (scarsa autonomia negli spostamenti, ecc.);
  - assenza di supporto familiare o sociale;
  - difficoltà economiche;
  - importante compromissione dei livelli di funzionalità fisica;
  - difficile accesso alla struttura sanitaria;
  - discontinuità assistenziale.

  il trattamento. In questo senso, il ruolo degli ICM impegnati nell'ambulatorio territoriale dello scompenso cardiaco assume un ruolo centrale e strategico nella presa in carico del paziente e nella funzione di trait d'union tra ospedale e territorio.

▶ *PDTA con presenza di indicatori sull'aderenza*

UMBRIA

	Indicatore di esito
	«Valutazione del grado di adesione/persistenza al trattamento da parte dei pazienti inclusi sempre utilizzando i dati di consumo ottenuti dal data-base regionale»

MARCHE

Gli indicatori P1-P2 sono mutuati dal "Nuovo sistema di garanzia (NSG) per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria (GU n.138 del 14-6-2019): Valutazione dei percorsi diagnostico terapeutico assistenziali".

	Indicatori di processo					
	Codice	**Definizione**	**Flussi**	**Numeratore**	**Denominatore**	**Fonte**
	P1	Adeguatezza (percentuale) dell'aderenza al trattamento farmacologico con ACE-inibitori o sartani	• Anagrafe assistiti • Farmaceutica territoriale • Distribuzione diretta dei farmaci • SDO	Numero di pazienti appartenenti ai "casi prevalenti" con una prescrizione di ACE-inibitori o sartani nei 3 mesi successivi alla data di dimissione del ricovero indice e con una proporzione di giorni coperti dal farmaco nei successivi 12 mesi ≥75%	Numero di pazienti appartenenti ai "casi prevalenti" con una prescrizione di ACE-inibitori o sartani nei 3 mesi successivi alla data di dimissione del ricovero indice	NSG
	P2	Adeguatezza (percentuale) dell'aderenza al trattamento farmacologico con beta-bloccanti	• Anagrafe assistiti • Farmaceutica territoriale • Distribuzione diretta dei farmaci • SDO	Numero di pazienti appartenenti ai "casi prevalenti" con una prescrizione di beta-bloccanti nei 3 mesi successivi alla data di dimissione del ricovero indice e con una proporzione di giorni coperti dal farmaco nei successivi 12 mesi ≥75%	Numero di pazienti appartenenti ai "casi prevalenti" con una prescrizione di beta-bloccanti nei 3 mesi successivi alla data di dimissione del ricovero indice	NSG

LAZIO

	Indicatore di processo	
	Verifica della aderenza terapeutica	Paz. con aderenza rilevata / N. tot paz. presi in carico * 100

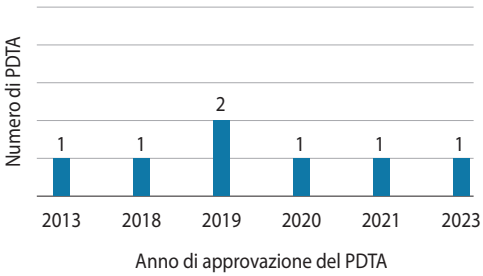
L'analisi dei PDTA dell'Infarto Miocardico Acuto

Distribuzione geografica e anno di approvazione

Fino al 31 dicembre 2023 sono stati rinvenuti 7 PDTA regionali per l'IMA, nelle Regioni Umbria, Basilicata, Trento, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Sicilia e Toscana (**Figura 7**). Questi PDTA sono stati approvati (e/o aggiornati) tra il 2013 e il 2023 (**Figura 8**).

Figura 7. La distribuzione geografica dei PDTA regionali dell'infarto del miocardio

Figura 8. Approvazioni di PDTA regionali per l'infarto miocardico acuto negli anni



I riferimenti normativi

Di seguito si riporta l'elenco dei documenti analizzati con i relativi riferimenti normativi:

- UMBRIA, "Protocollo operativo per la gestione dei pazienti con Infarto Miocardio Acuto con sopra livellamento del tratto ST (STEMI)", 2013 (DGR n. 978 del 09/09/2013);
- BASILICATA, "Protocollo diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico e trattamento del paziente e della paziente con infarto miocardico acuto con sopra livellamento del tratto st (STEMI)", 2018 (Delibera n. 131 del 14.2.2018);
- TRENTO, "PDTA dell'infarto miocardico acuto con STEMI + Percorso aziendale di riabilitazione cardiologica", 2019 (Documento APSS del 24.12.2019);
- FRIULI-VENEZIA GIULIA, "Percorso assistenziale del paziente con infarto miocardico con sopra livellamento tratto st (STEMI)", 2019 (Doc DCS gennaio 2019);
- MARCHE, "Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione del paziente con infarto miocardico acuto (IMA) con sopra livellamento del tratto ST (STEMI) sul territorio marchigiano", 2020 (DGR n. 1078 del 3 agosto 2020);
- SICILIA, "Rete per l'infarto miocardico acuto in Sicilia + Documento di indirizzo regionale "Criteri di appropriatezza nel follow-up clinico strumentale dei pazienti dopo sindrome coronarica acuta (SCA)", 2021 (D.A. n. 2196 del 6 dicembre 2019);
- TOSCANA, "Linee di indirizzo regionali per le reti cliniche tempo-dipendenti Rete Emergenze Cardiologiche - Infarto miocardico acuto", 2023 (Decisione del comitato scientifico n. 40 del 12/10/2023).

L'analisi dell'aderenza

L'analisi dell'aderenza dei 7 PDTA dell'IMA approvati fino al 31 dicembre 2023 ha evidenziato che 3 documenti non affrontano il tema dell'aderenza alle prescrizioni farmacologiche, mentre 4 lo affrontano in modo lieve (Regioni Basilicata, Trentino Alto-Adige, Friuli-Venezia Giulia, Toscana) Solamente il PDTA del Friuli-Venezia Giulia presenta specifici indicatori di aderenza, annoverati tra quelli di processo (**Tabella 2**).

Tabella 2. Analisi dell'aderenza per i PDTA dell'Infarto Miocardico Acuto (livello di approfondimento e presenza di indicatori)

	Anno PDTA	Livello di approfondimento sul tema di interesse*	Indicatori	Tipologia di indicatore
Umbria	2013	0		
Basilicata	2018	1		
Trento	2019	1		
Friuli V.G.	2019	1	✓	i. di processo
Marche	2020	0		
Sicilia	2021	0		i. di esito
Toscana	2023	1		

▶ *PDTA con aderenza "accennata": esempi*

BASILICATA

Nel PDTA della Basilicata il tema dell'aderenza è accennato nelle fasi della riabilitazione cardiologica, in particolare nella Fase 2, per la quale si specifica che: "La seconda fase (Fase 2) si svolge durante la fase post acuta della malattia, generalmente in regime ambulatoriale o, eventualmente, a domicilio del paziente e prevede un programma strutturato di attività fisica e supporto educativo e psicologico, con percorsi finalizzati a modificare i principali fattori di rischio. in varie sezioni dedicate alla descrizione dei ruoli e compiti dei professionisti sanitari, come medico di medicina generale (MMG) e infermiere."

Fase		Obiettivi	Struttura di intervento (DCR 317/2012)	Luogo di attività
0	**Fase della prevenzione del danno secondario e delle conseguenti menomazioni**			
1	**Fase della riabilitazione intensiva**			
2	**Fase della riabilitazione estensiva di completamento del processo di recupero** e del progetto di riabilitazione	Sorveglianza dei fattori di rischio, **controllo farmacologico**, strutturazione programma attività fisica, counselling psicologico. predisposizione alla Fase 3	U.O. di Recupero e riabilitazione cardiologica	Ambulatorio
3	**Fase di mantenimento e/o di prevenzione della progressione della disabilità**			

TRENTINO ALTO ADIGE

Nel PDTA della Regione Trentino-Alto Adige, il tema dell'aderenza è accennato nella sezione della cardiologia riabilitativa:

- Riabilitazione di FASE 2 e di FASE 3 – attività di Day Care presso una struttura di riabilitazione cardiologica

Valutazioni da effettuare all'ingresso: • valutazione clinica del paziente; • verifica dell'efficacia, tolleranza e aderenza alla terapia farmacologica; • valutazione delle condizioni psicologiche, al fine della prevenzione o cura delle possibili complicanze ansiose e/o depressive legate alla malattia.

- Criteri di accesso alla riabilitazione cardiologica in base al profilo di rischio dei pazienti

	Percorso assistenziale dei pazienti a rischio più basso
	I pazienti senza SC e/o disfunzione ventricolare sinistra e senza rischio trombotico elevato possono essere considerati a più basso rischio e, pertanto, possono avvalersi di trattamenti riabilitativi anche in regime ambulatoriale. Ad essi vanno comunque garantiti: • **indicazioni rispetto alla terapia farmacologica da seguire e all'importanza di una adeguata aderenza alla stessa;** • una corretta informazione sulla propria malattia ed una corretta educazione sui corretti stili di vita da seguire (es., abolizione del fumo, dieta più indicata, ecc.).

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nel PDTA della Regione Friuli-Venezia Giulia, il tema dell'aderenza è accennato in varie sezioni, quali:

- Cardiologia Riabilitativa degenziale intensiva e ambulatoriale

La Cardiologia Riabilitativa si occupa della gestione del paziente cardiovascolare post-acuto nella sua totalità e si avvale di un team multidisciplinare e multiprofessionale articolando il suo percorso attraverso i seguenti interventi: • valutazione del paziente e assistenza sanitaria volta alla stabilizzazione clinica; • stratificazione prognostica con valutazione del rischio cardiovascolare globale residuo; • definizione della terapia medica ottimizzata secondo le più recenti Linee Guida, con interventi specifici per favorire • l'aderenza a medio e lungo termine; • prescrizione dell'attività fisica (dal ricondizionamento al training fisico) con counselling specifico; • valutazione e counselling nutrizionale; • gestione del peso corporeo; • ….

- Ambulatorio infermieristico

Gli obiettivi dell'ambulatorio infermieristico sono:

- il counselling ad integrazione e supporto dell'intervento medico;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi di prevenzione secondaria.

L'intervento educativo motivazionale personalizzato è rivolto al rinforzo dell'aderenza agli stili di vita (alimentazione, attività fisica…) **e al programma terapeutico** al fine di ottimizzare il controllo dei fattori di rischio CV, promuovendo la responsabilizzazione del paziente ed i comportamenti di automonitoraggio (misurazione regolare della pressione, frequenza cardiaca, peso corporeo) e concordando gli obiettivi da raggiungere.

PDTA con presenza di indicatori sull'aderenza

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Fase post-ospedaliera: Riabilitazione post-dimissione - Indicatori di processo:

- Prescrizione aspirina, statine e beta-bloccanti alla dimissione.
- **Persistenza di terapia con statine e percentuale pazienti con LDL a target a 1 anno (obiettivo 85% < 70 mg/dl)**
- Presa in carico: Percentuale di visite di follow-up a 1 mese dalla dimissione (obiettivo 80%) dei pazienti con diagnosti di STEMI.
- Percorso di counselling strutturato: evidenza di almeno una visita infermieristica nel primo anno dopo la dimissione (invio a Cardiologia Riabilitativa o ambulatorio infermieristico).

CONCLUSIONI

PDTA Net, al 31 dicembre 2023, ha raccolto 48 PDTA di patologie cardiovascolari, e lo scompenso cardiaco e l'IMA risultano le due maggiormente rappresentate, con 13 e 7 PDTA rispettivamente.[12] Lo scompenso cardiaco e l'IMA sono condizioni croniche a elevata prevalenza che rispondono a tutti i criteri di eleggibilità per essere gestite tramite un PDTA. La ricerca e l'analisi del tema dell'aderenza alla terapia farmacologica all'interno dei PDTA ha mostrato una grande eterogeneità in questi documenti, che affrontano e approfondiscono in modo piuttosto diverso questo tema.

Occorre sottolineare che per entrambe le patologie cardiovascolari potrebbero essere stati deliberati svariati documenti aziendali (ASL e Aziende Ospedaliere) sparsi su tutto il territorio nazionale che tuttavia, non sono censiti nel sistema PDTA Net. Questo, infatti, raccoglie esclusivamente i documenti regionali, in quanto si è ritenuto che il PDTA, per essere implementato, necessiti di essere inserito all'interno di un determinato modello organizzativo regionale.

I 13 PDTA regionali riguardanti lo scompenso cardiaco sono stati deliberati dalle Regioni Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, Umbria, Calabria, Basilicata, Toscana, Abruzzo, Campania, Marche e Molise. Di questi 13 PDTA, tutti affrontano il tema dell'aderenza, ma soltanto quello della Regione Abruzzo (2021) lo approfondisce in modo esaustivo. Infatti, oltre a vari accenni nelle sezioni dedicate alla descrizione dei ruoli e compiti dei professionisti sanitari, come medico di medicina generale e infermiere, è presente uno specifico paragrafo dedicato a questo tema. Tuttavia, questo PDTA manca di specifici indicatori per la valutazione dell'aderenza, indicatori che risultano invece presenti in 3/15 PDTA, delle Regioni Lazio (2015), Umbria (2017) e Marche (2021). Le Regioni e Lazio Marche li classificano tra gli indicatori di processo, mentre la Regione Umbria tra gli indicatori di esito.

I 7 PDTA regionali riguardanti l'IMA sono stati deliberati dalle Regioni Umbria, Basilicata, Trento, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Sicilia e Toscana. In essi, il tema dell'aderenza è poco affrontato. Infatti, tre PDTA non affrontano affatto questo tema, mentre quattro lo trattano, ma in modo lieve e superficiale. In questi PDTA, delle regioni Basilicata, Trentino Alto-Adige e Friuli-Venezia Giulia, il tema dell'aderenza è per lo più presente nelle sezioni relative alla riabilitazione cardiologica. Inoltre, soltanto nel documento del Friuli-Venezia Giulia prevede degli specifici indicatori, di processo, per il monitoraggio dell'aderenza.

In conclusione, l'analisi dei PDTA ha mostrato che il tema dell'aderenza alle prescrizioni farmacologiche è scarsamente affrontato all'interno dei documenti regionali. Inoltre, nessuno dei 20 documenti analizzati (13 per lo scompenso cardiaco e 7 per l'IMA) riporta in maniera appropriata e applicabile indicatori di monitoraggio dell'aderenza, sebbene le ricadute di una scarsa aderenza, sia in termini clinici sia economici, siano ben note.

BIBLIOGRAFIA

1. Sabaté E. Adherence to Long-Term Therapies: Evidence for Action, World Health Organization, Geneva, Switzerland, 2003.
2. Squillace A, Nardi S, Aceti T. Raccomandazione civica per l'aderenza terapeutica, Cittadinanzattiva, 2018.
3. Agenzia Italiana del Farmaco. Aderenza alle terapie e strategie per migliorare l'uso sicuro ed efficace dei farmaci. 2014. https://www.aifa.gov.it/-/aderenza-alle-terapie-e-strategie-per-migliorare-l-uso-sicuro-ed-efficace-dei-farmaci [ultimo accesso: 13 giugno 2024].
4. MaCroScopio (Osservatorio sulla cronicità). Aderenza, deprescribing e PDTA. Il Pensiero Scientifico Editore, 2023.
5. Martini N, Piccinni C. Il lungo percorso verso l'aderenza. Recenti Prog Med. 2021 Sep;112(9):553-555.
6. Chen C, Li X, Su Y, et al. Adherence with cardiovascular medications and the outcomes in patients with coronary arterial disease: "Real-world" evidence. Clin Cardiol. 2022 Dec;45(12):1220-1228.
7. MaCroScopio (Osservatorio sulla cronicità). Valuta PDTA. Il Pensiero Scientifico Editore, 2022.
8. Ministero della Salute. Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria. DM 12 marzo 2019. G.U. Serie Generale, n. 138, del 14 giugno 2019.
9. Piccinni C, Calabria S, Ronconi G, et al. I numeri dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) in Italia: risultati dal progetto PDTA Net. Recenti Prog Med 2019;110(4):188-194.
10. Dell'Anno I, Calabria S, Dondi L, et al. Conoscere i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (Pdta) regionali approvati in Italia per affrontare il cambiamento della assistenza di prossimità: analisi quali-quantitativa del database Pdta Net. Recenti Prog Med 2023;114(1):792-801.
11. Dell'Anno I, Calabria S, Martini N, Piccinni C. PDTA Net: una risorsa per la riforma dell'assistenza di prossimità. CARE 2023; (6): 14-5.
12. Dell'Anno I, Calabria S, Martini N, et al. Aggiornato l'Osservatorio Pdta Net di Fondazione ReS con tutti i Pdta regionali approvati fino al 2023. Recenti Prog Med 2024;115(6):267-270.
13. MaCroScopio (Osservatorio sulla Cronicità). Costruisci PDTA. Il Pensiero Scientifico Editore, 2020.
14. Istituto Superiore di Sanità – Settore Documentazione, Medical Subject Headings – Traduzione Italiana. 2017

Abbvie

AstraZeneca

Daiichi Sankyo Italia

GlaxoSmithKline

Italfarmaco

Menarini Group

Roche

Servier

ViiV Healthcare